ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

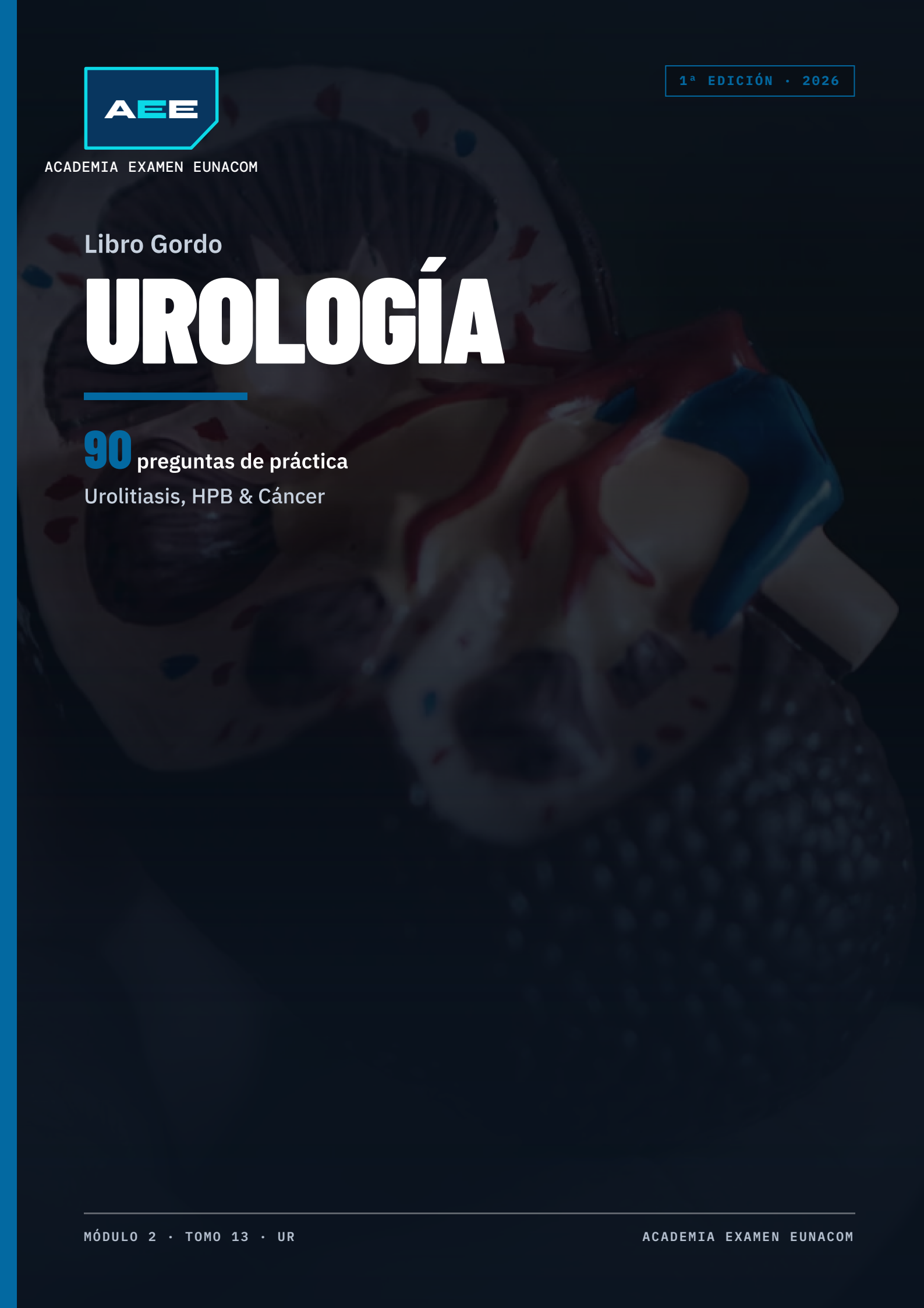
1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

UROLOGÍA

90 preguntas de práctica

Urolitiasis, HPB & Cáncer



MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Urología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA					
4.01.1.007	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q4, Q5, Q6, Q7	Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5)
4.01.2.001	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q12, Q13	Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9)
4.03.1.001	Balanitis, balano postitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q1	Tomo 13 · 13.16 (Pág. 28)
4.03.1.009	Fimosis, parafimosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q2	Tomo 13 · 13.16 (Pág. 28)
4.03.1.013	Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q18	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.015	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q8	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.016	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q9	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.025	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.026	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q14	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.027	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q15	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.001	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.003	Parafimosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.005	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.006	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q17	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
BLOQUE 2: UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA					
1.04.1.010	Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q32, Q33, Q34	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.08.1.009	Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q22, Q23, Q24	Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.025	Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q22, Q23, Q24	Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15)
4.01.2.002	Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q26, Q27, Q28, Q29	Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20)
4.03.1.004	Criptorquídea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q19	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.007	Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q35, Q36	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.012	Hidronefrosis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.014	Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q25	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.024	Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.004	Priapismo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 13 · 13.16 (Pág. 28)
4.03.2.007	Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
BLOQUE 3: URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO					
1.12.1.001	Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q46, Q47, Q48, Q49	Tomo 13 · 13.8 (Pág. 35)
4.01.1.013	Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q52, Q53, Q54	Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15)
4.01.1.018	Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q40, Q41, Q42	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.03.1.002	Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.005	Disfunción sexual de causa orgánica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 13 · 13.16 (Pág. 28)
4.03.1.011	Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q43	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.017	Infertilidad masculina	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.020	Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q44	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.028	Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q45	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.008	Trauma urológico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 4: URO-ONCOLOGÍA					
1.12.1.002	Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q60, Q61, Q62, Q63	Tomo 13 · 13.10 (Pág. 41)
4.03.1.003	Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q67, Q68	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.006	Enfermedades de transmisión sexual	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q55	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.010	Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q69	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.019	Malformaciones congénitas nefrourológicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.022	Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q64, Q65, Q66	Tomo 13 · 13.11 (Pág. 45)
4.03.1.023	Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70, Q71	Tomo 13 · 13.12 (Pág. 47)
4.03.2.002	Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q72	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.009	Traumatismo uretral	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57, Q58, Q59	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
BLOQUE 5: INFECCIONES UROLÓGICAS, QUISTES & HEMATURIA					
1.07.1.001	Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q86, Q87, Q88, Q89, Q90	Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85)
1.09.1.001	Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q80, Q81, Q82, Q83, Q84	Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37)
1.11.1.006	Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	Tomo 13 · 13.13 (Pág. 52)
4.03.1.008	Estenosis uretral	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.018	Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q85	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.021	Reflujo vésico ureteral	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Urología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 13 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.04.1.010	Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q32, Q33, Q34	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.07.1.001	Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q86, Q87, Q88, Q89, Q90	Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85)
1.08.1.009	Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q22, Q23, Q24	Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56)
1.09.1.001	Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q80, Q81, Q82, Q83, Q84	Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37)
1.11.1.006	Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	Tomo 13 · 13.13 (Pág. 52)
1.12.1.001	Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q46, Q47, Q48, Q49	Tomo 13 · 13.8 (Pág. 35)
1.12.1.002	Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q60, Q61, Q62, Q63	Tomo 13 · 13.10 (Pág. 41)
4.01.1.007	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q4, Q5, Q6, Q7	Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5)
4.01.1.013	Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q52, Q53, Q54	Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15)
4.01.1.018	Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q40, Q41, Q42	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.025	Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q22, Q23, Q24	Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15)
4.01.2.001	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q12, Q13	Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9)
4.01.2.002	Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q26, Q27, Q28, Q29	Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20)
4.03.1.001	Balanitis, balano postitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q1	Tomo 13 · 13.16 (Pág. 28)
4.03.1.002	Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.003	Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q67, Q68	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.004	Criptorquídea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q19	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.03.1.005	Disfunción sexual de causa orgánica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 13 · 13.16 (Pág. 28)
4.03.1.006	Enfermedades de transmisión sexual	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q55	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.007	Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q35, Q36	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.008	Estenosis uretral	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.009	Fimosis, parafimosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q2	Tomo 13 · 13.16 (Pág. 28)
4.03.1.010	Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q69	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.011	Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q43	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.012	Hidronefrosis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.013	Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q18	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.014	Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q25	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.015	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q8	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.016	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q9	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.017	Infertilidad masculina	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.018	Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q85	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.019	Malformaciones congénitas nefrourológicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.020	Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q44	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.021	Reflujo vésico ureteral	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.022	Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q64, Q65, Q66	Tomo 13 · 13.11 (Pág. 45)
4.03.1.023	Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70, Q71	Tomo 13 · 13.12 (Pág. 47)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.03.1.024	Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.025	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.026	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q14	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.027	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q15	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.028	Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q45	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.001	Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.002	Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q72	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.003	Parafimosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.004	Priapismo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 13 · 13.16 (Pág. 28)
4.03.2.005	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.006	Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q17	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.007	Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.008	Trauma urológico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.009	Traumatismo uretral	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57, Q58, Q59	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

PREGUNTA 1 4.03.1.001

1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Balanitis, balano postitis · 4.03.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Balanitis, balano postitis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 4.03.1.009

2. Un niño de 3 años acude a control sano. Su madre refiere que tiene estrechez del prepucio y, al examen físico, se confirma que el prepucio es irreductible . ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aplicar ungüento antibiótico

B) Realizar tracción manual forzada del prepucio

C) Realizar circuncisión

D) Aplicar ungüento de corticoide tópico

E) Controlar en un año

PREGUNTA 3 4.03.2.003

3. [URGENCIA: Parafimosis · 4.03.2.003] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Parafimosis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 4 4.01.1.007

4. Hombre de 35 años consulta a urgencias por dolor lumbar derecho brusco de 2 horas de evolución, irradiado a testículo ipsilateral, acompañado de gran inquietud motora y vómitos. Signos vitales: PA 140/85 mmHg, FC 98 lpm, afebril (36.6 °C). Al examen: abdomen blando sin peritonismo, puñopercusión lumbar derecha dolorosa. Tras administrar ketorolaco EV con excelente alivio del dolor, ¿cuál es el examen de elección para evaluar el tamaño y ubicación exacta del cálculo?

A) Ecografía renal y vesical con Doppler

B) TAC de abdomen y pelvis sin contraste (Pielotac)

C) Urografía excretora con medio de contraste yodado

D) Radiografía simple de abdomen en bipedestación

E) Resonancia magnética de vías urinarias (Uro-RM)

PREGUNTA 5 4.01.1.007

5. Mujer de 28 años con diagnóstico tomográfico de litiasis en tercio medio del uréter derecho de 7 mm de diámetro mayor, no obstructiva severa. El dolor fue controlado satisfactoriamente en urgencias. Función renal normal y sedimento sin signos de infección. ¿Cuál es la conducta terapéutica ambulatoria más adecuada?

A) Observación simple con analgesia a demanda sin fármacos adicionales

B) Terapia médica expulsiva con tamsulosina 0.4 mg/día por hasta 4 semanas

C) Indicación inmediata de litotripsia extracorpórea de urgencia

D) Nefrolitotomía percutánea ambulatoria

E) Instalación de catéter Doble J profiláctico bajo anestesia local

PREGUNTA 6 4.01.1.007

6. Hombre de 52 años monorreno quirúrgico derecho consulta en el Servicio de Urgencias por dolor lumbar izquierdo sordo y sensación nauseosa de 8 horas de evolución. Refiere que no ha orinado en las últimas 6 horas (anuria confirmada). Exámenes: Creatinina 4.1 mg/dL (basal 1.1 mg/dL), K 5.8 mEq/L. TAC sin contraste revela lito impactado de 9 mm en la unión pieloureteral izquierda con dilatación pielocalicial moderada. ¿Cuál es la conducta prioritaria inmediata?

A) Infusión endovenosa de 2.000 mL de suero fisiológico para forzar diuresis

B) Hemodiálisis urgente por catéter venoso central y diferir urología

C) Descompresión urológica urgente de la vía urinaria con catéter Doble J o nefrostomía

D) Iniciar tamsulosina 0.4 mg oral y esperar 48 horas de evolución

E) Administrar furosemida 80 mg endovenosa en bolo directo

PREGUNTA 7 4.01.1.007

7. **Paciente de 44 años con antecedentes de tres episodios previos de cólico renal por cálculos de oxalato de calcio. En su estudio metabólico ambulatorio se confirma hipercalciuria idiopática con calcemia y función renal normales. Además de asegurar una ingesta hídrica mayor a 3 litros al día y restricción de sodio, ¿cuál es el fármaco de elección para prevenir nuevas recurrencias?**

A) Alopurinol 300 mg/día
B) Citrato de potasio oral
C) Hidroclorotiazida 25 a 50 mg/día
D) Furosemida 20 mg/día
E) Carbonato de calcio con las comidas

PREGUNTA 8 4.03.1.015

8. **Se a8ende a una paciente de 26 años con antecedente de infecciones del tracto urinario a repe8ción desde hace 4 años, coincidiendo con el inicio de sus relaciones sexuales. Ha presentado urocul8vos posi8vos para Escherichia coli con una frecuencia de 5 a 6 episodios por año. Su examen Fsico actual es normal, el urocul8vo es nega8vo y el panel de PCR para infecciones de transmisión sexual también resulta nega8vo. Una ecograFa renal y vesical previa resultó normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cistoscopía
B) Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina
C) Iniciar flavoxato vía oral
D) Profilaxis an2bió2ca poscoital
E) Indicar uso de preserva2vo durante las relaciones sexuales

PREGUNTA 9 4.03.1.016

9. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Infección urinaria específica · 4.03.1.016] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Infección urinaria específica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 10 4.03.1.025

10. **Un paciente de 42 años presenta eliminación de un cálculo en orina, el cual no pudo recuperar para análisis. Se realiza estudio metabólico en orina de 24 horas con calcio, fósforo, citrato y uratos, todos dentro del rango normal, al igual que su perfil bioquímico en sangre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la ingesta de agua
B) Iniciar alopurinol oral
C) Realizar litrotricia extracorpórea
D) Indicar dieta baja en lácteos
E) Indicar dieta rica en vegetales

PREGUNTA 11 4.03.2.001

11. **Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?**

A) UroTAC
B) PieloTAC
C) Pielografía de eliminación intravenosa
D) Ecografía
E) Radiografía simple

PREGUNTA 12 4.01.2.001

12. **Hombre de 24 años es traído a la urgencia tras sufrir un accidente en motocicleta con impacto en el periné contra el estanque. Al examen físico se observa sangre en el meato uretral (uretrorragia) y un voluminoso hematoma perineal en alas de mariposa. El paciente refiere intensos deseos de orinar pero no lo logra, palpándose un globo vesical a tensión. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para descomprimir la vía urinaria?**

A) Instalar sonda Foley 18 Fr lubricada con lidocaína jalea con técnica estéril
B) Realizar cistostomía suprapúbica percutánea con trocar
C) Indicar analgesia potente y esperar relajación del esfínter externo
D) Intentar cateterismo con sonda nelaton semirrígida de pequeño calibre
E) Administrar tamsulosina oral y solicitar ecografía vesical de rutina

PREGUNTA 13 4.01.2.001

13. **Varón de 69 años con retención urinaria aguda de 12 horas es sondado con éxito en urgencias mediante sonda Foley, evacuándose de forma inmediata 1.400 mL de orina clara. El paciente refiere alivio inmediato del dolor. ¿Cuál es la complicación fisiopatológica que debe monitorizarse con mayor atención en las primeras 24 horas?**

A) Reflejo vasovagal sostenido con paro cardíaco
B) Síndrome de diuresis post-obstructiva con deshidratación e hipokalemia
C) Estenosis uretral isquémica precoz
D) Necrosis tubular aguda anúrica irreversible
E) Hematuria ex vacuo masiva con shock hipovolémico

PREGUNTA 14 4.03.1.026

14. [ATENCIÓN PRIMARIA: Uropatía alta · 4.03.1.026] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Uropatía alta. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 15 4.03.1.027

15. [ATENCIÓN PRIMARIA: Uropatía obstructiva baja · 4.03.1.027] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Uropatía obstructiva baja. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 4.03.2.005

16. Un paciente de 56 años consulta por disminución del calibre miccional, asociado a disuria de esfuerzos de 3 meses de evolución. Hace 7 días se agrega disuria, polaquiuria y malestar. Se solicita APE, que resulta 14,7 ng/ml (valor normal: menor a 4 ng/ml). El tratamiento inicial más adecuado es:

A) Tamsulosina
B) Nitrofurantoína
C) Ciprofloxacino
D) Dutasteride
E) Doxazosina

PREGUNTA 17 4.03.2.006

17. Hombre de 70 años con HPB conocida llega a urgencias con incapacidad de orinar desde hace 8 horas, vejiga palpable en hipogastrio y dolor intenso. ¿Cuál es el manejo inicial de elección?

A) Sonda Foley vesical
B) Diurético EV
C) Alfa-bloqueador oral y esperar
D) Cistostomía suprapúbica inmediata
E) Cateterismo intermitente

PREGUNTA 18 4.03.1.013

18. Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y diabetes mellitus en tratamiento con metformina y glibenclamida, presenta desde hace 3 meses y en forma progresiva, poliaquiuria y nicturia, asociado a latencia, chorro miccional doble y débil. Al examen físico se palpa próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Se solicita antígeno prostático que resulta en 3,5ng/ml. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar prostatectomía vía resección transuretral
B) Realizar prostatectomía por vía retropúbica
C) Indicar alfa agonista
D) Indicar inhibidor de la 5 alfa reductasa
E) Indicar análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas

BLOQUE 2 UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

PREGUNTA 19 4.03.1.004

19. [ATENCIÓN PRIMARIA: Criptorquídea · 4.03.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Criptorquídea. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 20 4.03.1.012

20. **Un paciente de 18 años consulta por dolor lumbar izquierdo, de larga evolución. Al examen físico tiene una masa en el flanco izquierdo, por lo que se solicita una ecografía abdominal, que muestra una hidronefrosis izquierda, con adelgazamiento de la corteza renal, sin dilatación uretral. Su creatinina plasmática es 0,9 mg/dl y su sedimento de orina no presenta alteraciones. La cintigrafía renal muestra captación de 90% a derecha y 10% a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar pieloplastía izquierda
B) Realizar nefrostomía percutánea
C) Realizar nefrectomía izquierda
D) Instalar sonda Foley
E) Solicitar pieloTAC

PREGUNTA 21 4.03.2.004

21. **Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen se corrobora que tiene erección completa, pero turgencia solo de los cuerpos cavernosos, con glande y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Aplicar hielo en la zona genital
B) Realizar derivación cavernoesponjosa de urgencia
C) Administrar atropina intracavernosa
D) Administrar analgésicos endovenosos
E) Administrar fenilefrina intracavernosa

PREGUNTA 22 4.01.1.025, 1.08.1.009

22. **Mujer de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial consulta por escapes urinarios frecuentes. Describe que siente un deseo incontenible de orinar y que 'no alcanza a llegar al baño', perdiendo un volumen importante de orina. Se levanta a orinar 4 veces cada noche. Examen ginecológico sin distopia genital relevante. Sedimento de orina estéril y residuo postmiccional de 20 mL. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más apropiado para su condición?**

A) Instalación de malla suburetral transobturatriz (TOT)
B) Oxibutinina o Mirabegrón oral
C) Cateterismo vesical intermitente cada 6 horas
D) Pseudoefedrina oral 60 mg cada 12 horas
E) Estrógenos locales en crema como monoterapia

PREGUNTA 23 4.01.1.025, 1.08.1.009

23. **Hombre de 68 años con diabetes mellitus de 20 años de evolución con neuropatía periférica severa consulta por incontinencia urinaria de 3 meses. Refiere que moja la ropa interior constantemente con un goteo continuo indoloro sin sentir deseos de orinar. El examen físico revela hipoestesia distal en calcetín y una masa blanda palpable en hipogastrio. ¿Cuál es el examen inicial indispensable para orientar el manejo de este paciente?**

A) Cistoscopía diagnóstica de urgencia
B) Medición del residuo postmiccional ecográfico o por cateterismo
C) Urografía retrógrada con contraste
D) Biopsia transrectal de próstata
E) Urodinamia multicanal invasiva de entrada

PREGUNTA 24 4.01.1.025, 1.08.1.009

24. **Mujer de 48 años que consulta por incontinencia de esfuerzo. Se le explican los ejercicios de Kegel. ¿En qué consiste exactamente esta técnica kinesiológica?**

A) Pujar repetidamente contrayendo la prensa abdominal mientras se orina
B) Contracciones voluntarias repetidas del músculo pubococcígeo y suelo pélvico sin activar glúteos ni abdomen
C) Aguantar la micción por periodos de más de 8 horas continuas
D) Interrumpir activamente el chorro de orina cada vez que se va al baño a orinar
E) Maniobras de compresión manual suprapúbica para forzar el vaciamiento vesical

PREGUNTA 25 4.03.1.014

25. **Una paciente de 60 años presenta incon8nencia urinaria de 2 años de evolución, caracterizada por escapes de orina precedidos por urgencia miccional incontrolable, por lo que u8liza 3 a 5 protectores al día. Su examen Fsico es normal, al igual que su exploración ginecológica. Se solicita una ecograFa abdominal que muestra vía urinaria de calibre normal y vejiga urinaria sin lesiones, con residuo postmiccional de 30 cc. ¿Qué fármaco es más adecuado como tratamiento de primera línea?**

A) Bloqueadores alfa adrenérgicos
B) Bloqueadores beta adrenérgicos
C) Agonistas adrenérgicos
D) An2colinérgicos muscarínicos
E) Estrógenos

PREGUNTA 26 4.01.2.002

26. **Niño de 13 años consulta por dolor testicular derecho de inicio brusco e intenso hace 3 horas mientras dormía, acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico: testículo derecho retraído hacia la parte superior del escroto, horizontalizado y muy sensible a la palpación. El reflejo cremastérico derecho está ausente. El centro asistencial no cuenta con ecógrafo disponible en turno de noche. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe adoptarse?**

A) Indicar ketorolaco EV y trasladar en ambulancia para Eco Doppler a un hospital terciario a 2 horas de distancia
B) Exploración quirúrgica inmediata en pabellón por sospecha fundada de torsión testicular
C) Iniciar tratamiento empírico con ceftriaxona más doxiciclina y citar a control en 24 horas
D) Instalar suspensorio escrotal, aplicar frío local y dar de alta con reposo absoluto
E) Solicitar sedimento de orina y urocultivo antes de decidir interconsulta a urología

PREGUNTA 27 4.01.2.002

27. Escolar de 9 años es traído por su madre por presentar molestias en el testículo izquierdo de 24 horas de evolución. El dolor es leve a moderado y ha caminado sin dificultad. Al examen físico el testículo izquierdo se palpa de consistencia normal, en posición anatómica eutópica. El reflejo cremastérico está intacto y simétrico bilateralmente. En el polo superior del testículo izquierdo se palpa un nódulo indurado de 4 mm muy sensible, observándose a través de la piel escrotal una pequeña mancha azulada circunscrita. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección?

A) Torsión testicular; exploración quirúrgica urgente
B) Torsión de hidátide de Morgagni; tratamiento médico con reposo y analgésicos AINEs
C) Epididimitis bacteriana; antibioticoterapia con amoxicilina oral por 10 días
D) Orquitis urliana; aislamiento y corticoides sistémicos
E) Tumor testicular de células germinales; orquiectomía inguinal radical

PREGUNTA 28 4.01.2.002

28. Durante la exploración quirúrgica de urgencia por torsión testicular izquierda en un paciente de 15 años operado a las 8 horas de evolución, el cirujano constata un testículo intensamente congestivo y violáceo. Se realiza la destorsión y tras 15 minutos de compresas tibias, el parénquima recupera una coloración rosada saludable y presenta sangrado rutilante a la mínima incisión de la albugínea. Se fija el testículo al escroto izquierdo. ¿Cuál es el paso quirúrgico indispensable que resta por realizar antes de cerrar la herida?

A) Realizar biopsia en cuña del testículo izquierdo para certificar viabilidad microscópica
B) Exploración y orquidopexia profiláctica del testículo contralateral derecho
C) Instalación de prótesis testicular protésica inmediata
D) Sección del músculo cremáster derecho a través del conducto inguinal
E) Infiltración del cordón derecho con toxina botulínica

PREGUNTA 29 4.01.2.002

29. Joven de 16 años ingresa a urgencias con dolor testicular derecho intenso de 1 hora de evolución. Al examen físico se constata testículo derecho horizontalizado y muy sensible. El médico de turno decide intentar una maniobra de destorsión manual mientras se prepara el pabellón. ¿Cuál es la dirección en que habitualmente debe rotarse el testículo derecho para lograr su destorsión?

A) De lateral hacia medial (hacia la línea media)
B) De medial hacia lateral (hacia el muslo derecho, como abriendo un libro)
C) Tracción axial cefálica firme sin rotación
D) Compresión anteroposterior sostenida durante 2 minutos
E) Rotación de 360 grados en sentido horario estricto

PREGUNTA 30 4.03.1.024

30. Un paciente de 30 años consulta por aumento de volumen escrotal derecho. Al exa- men físico se palpa un tumor en relación al testículo derecho. Se solicita ecografía testi- cular que visualiza una lesión sólida, de 3 cm de diámetro, sin vascularización, que re- emplaza al parénquima testicular, sin compromiso del epidídimo. ¿Cuál es la conducta?

A) Radioterapia
B) Quimioterapia
C) Orquiectomía radical
D) TAC de abdomen y pelvis
E) Biopsia testicular por punción

PREGUNTA 31 4.03.2.007

31. Un paciente de 16 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a náuseas. Al examen se palpa el testículo derecho muy doloroso y aumentado de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Torsión testicular
B) Torsión de la hidátide
C) Infarto testicular
D) Orquiepididimitis
E) Trombosis de varicocele

PREGUNTA 32 1.04.1.010

32. Hombre de 23 años consulta por dolor testicular derecho progresivo de 3 días de evolución, disuria y febrícula. Al examen físico se constata tumefacción y aumento de volumen del epidídimo derecho, con reflejo cremastérico presente y signo de Prehn positivo. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico de primera línea más adecuado para este paciente?

A) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 7 días en monoterapia
B) Ceftriaxona 500 mg IM dosis única más Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 10 días
C) Nitrofurantoína 100 mg cada 8 horas por 5 días
D) Azitromicina 500 mg dosis única como tratamiento exclusivo
E) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 14 días

PREGUNTA 33 1.04.1.010

33. Varón de 64 años con antecedentes de hiperplasia prostática benigna consulta por dolor y aumento de volumen en el hemiescroto izquierdo de 4 días de evolución, acompañado de disuria y fiebre de 38.4 °C. Al examen físico se palpa el testículo y epidídimo izquierdos muy sensibles y engrosados. El sedimento de orina muestra leucocituria abundante y piuria con bacterias móviles. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de su cuadro?

A) Neisseria gonorrhoeae
B) Chlamydia trachomatis serotipos D-K
C) Escherichia coli
D) Ureaplasma urealyticum
E) Virus de la parotiditis (Paramixovirus)

PREGUNTA 34 1.04.1.010

34. Hombre de 29 años en tratamiento antibiótico ambulatorio con ceftriaxona y doxiciclina desde hace 4 días por orquiepididimitis derecha. Reconsulta por persistencia de fiebre alta (39 °C), aumento progresivo del tamaño escrotal y dolor pulsátil insoportable. Al examen físico se palpa una zona claramente fluctuante y caliente en la pared posterior del testículo derecho. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica prioritaria?

A) Aumentar la dosis de doxiciclina y citar en una semana
B) Solicitar ecografía testicular Doppler y derivar a urología para eventual drenaje quirúrgico de un absceso
C) Indicar orquidopexia bilateral inmediata por sospecha de torsión agregada
D) Rotar antibióticos a ciprofloxacino oral y mantener manejo ambulatorio
E) Realizar punción con aguja fina en el box de atención primaria para evacuar el líquido

PREGUNTA 35 4.03.1.007

35. Un paciente de 60 años fue tratado hace 7 días con ciprofloxacino, por disuria. Hace dos días presenta dolor testicular izquierdo, asociado a fiebre. Al examen físico tiene aumento de volumen testicular, con dolor a la palpación, especialmente del conducto espermático. Se observa ligero edema escrotal, con eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hidrocele
B) Varicocele
C) Torsión testicular
D) Tumor testicular
E) Orquiepididimitis

PREGUNTA 36 4.03.1.007

36. Un paciente de 65 años consulta por dolor escrotal derecho de 3 días de evolución. Al examen físico presenta dolor y eritema en la zona escrotal derecha y se palpa au- mento de volumen y dolor, del testículo y del epidídimo. Refiere tener pareja sexual monogámica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pyogenes
B) Staphilococcus aureus
C) Chlamydia trachomatis
D) Neisseria gonorreae
E) Escherichia coli

BLOQUE 3 URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO

PREGUNTA 37 4.03.1.005

37. Hombre de 55 años con disfunción eréctil de 6 meses de evolución, sin causa aparente. HTA controlada con enalapril. Sin síntomas de hipogonadismo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (sildenafil o tadalafil)
B) Testosterona intramuscular
C) Alprostadil intracavernoso
D) Prótesis de pene
E) Solo consejería psicológica

PREGUNTA 38 4.03.1.017

38. Un hombre de 33 años, lleva 18 años intentando concebir un hijo con su pareja. Ella tiene reglas regulares y él tiene un examen físico y genital normal. ¿Con qué examen debemos iniciar el estudio en este paciente?

A) LH
B) FSH
C) Espermiograma
D) Cultivo de líquido seminal
E) Ecografía testicular

PREGUNTA 39 4.03.2.008

39. Un paciente de 35 años sufre un traumatismo lumbar de alta energía, evolucionando con hematuria. Al examen físico está hemodinámicamente estable, con FC: 75x' y PA: 120/80 mmHg. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico?

A) PieloTAC
B) UroTAC
C) Radiografía de abdomen simple
D) Ecografía renal
E) Pielografía de eliminación

PREGUNTA 40 4.01.1.018

40. Hombre de 58 años, previamente sano, consulta por notar hace 3 semanas un aumento de volumen indoloro en el lado derecho del escroto. Al examen físico se constata una masa varicosa tortuosa grado III en el cordón espermático derecho. Al acostar al paciente en decúbito dorsal sobre la camilla, la masa venosa permanece ingurgitada y no colapsa en absoluto. No hay dolor a la palpación. ¿Cuál es la conducta diagnóstica indispensable y prioritaria?

A) Indicar varicocelectomía subinguinal electiva ambulatoria
B) Solicitar espermiograma completo para evaluar fertilidad
C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste para descartar masa retroperitoneal o tumor renal
D) Tranquilizar al paciente explicando que es un proceso benigno degenerativo por la edad
E) Indicar uso de suspensorio escrotal elástico y citar en 6 meses

PREGUNTA 41 4.01.1.018

41. **Hombre de 32 años consulta por aumento progresivo de volumen del testículo derecho de 6 meses de evolución, sin dolor. Al examen físico se palpa una masa escrotal de 6 cm de diámetro, redondeada, lisa, elástica y no sensible. No es posible individualizar el testículo derecho dentro de la masa. Al apoyar la luz de una linterna en la cara posterior del escroto en penumbra, toda la masa se ilumina con un intenso halo rojo brillante homogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tumor testicular de células de Leydig
B) Hidrocele testicular no complicado
C) Varicocele grado III
D) Hernia inguinoescrotal incarcerada
E) Hematoma testicular crónico organizado

PREGUNTA 42 4.01.1.018

42. **Pareja de 28 años consulta por infertilidad primaria tras 14 meses de búsqueda sin éxito. El estudio de la mujer es completamente normal. El espermiograma del varón muestra concentración de 8 millones de espermatozoides/mL (oligospermia) con 25% de motilidad progresiva (astenospermia). En el examen físico se palpa un varicocele izquierdo grado II. ¿Cuál es el tratamiento que ha demostrado mayor eficacia para mejorar los parámetros seminales y la fertilidad en este paciente?**

A) Tratamiento con antioxidantes orales y vitamina E por 12 meses
B) Corrección quirúrgica del varicocele (varicocelectomía)
C) Inyecciones semanales de testosterona intramuscular
D) Punción evacuadora con escleroterapia percutánea del plexo
E) Enfriamiento testicular con bolsas de hielo dos veces al día

PREGUNTA 43 4.03.1.011

43. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Hidrocele · 4.03.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hidrocele. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 44 4.03.1.020

44. **Un paciente de 21 años, sin antecedentes, mientras jugaba futbol sufre golpe en zona testicular tras lo cual se palpa una masa. Al examen físico se palpa masa en polo superior blanda. Se solicita ecografía escrotal que muestra lesión quística en epidídimo de 3 cm de díametro, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Orquiectomía por vía inguinal
B) Punción y aspiración del quiste
C) Orquiectomía por vía escrotal
D) Observación
E) Indicar inhibidores de la 5 alfa reductasa

PREGUNTA 45 4.03.1.028

45. **Un adolescente de 15 años presenta dolor frecuente del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa aumento de volumen perotesticular, compatible con un varicocele y además se palpa el testículo izquierdo de menor tamaño que el testículo derecho. Se solicita una ecografía testicular que muestra una dilatación patológica del plexo pampiniforme.**

A) Observa evolución hasta que complete su desarrollo puberal
B) Realizar varicosectomía
C) Solicitar espermiograma
D) Realizar biopsia testicular
E) Solicitar cariograma y niveles de testosterona, LH y FSH

PREGUNTA 46 1.12.1.001

46. **Hombre de 61 años, asintomático, acude a control de salud. El tacto rectal revela una próstata de volumen normal, sin nódulos ni asimetrías. El informe de laboratorio indica un APE total de 6.2 ng/mL. Se descarta infección urinaria y se repite el examen a las 4 semanas, confirmándose un valor de 6.4 ng/mL con una relación APE libre/total de 9%. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A) Indicar tamsulosina 0.4 mg/día y controlar con APE en 1 año
B) Realizar biopsia prostática guiada por ecografía transrectal
C) Solicitar cintigrama óseo de cuerpo entero de entrada
D) Iniciar finasteride 5 mg/día por 6 meses para evaluar si el APE desciende
E) Tranquilizar al paciente indicando que al no haber nódulo palpable no hay riesgo oncológico

PREGUNTA 47 1.12.1.001

47. **Varón de 59 años consulta por chequeo prostático. Al tacto rectal se palpa un nódulo indurado pétreo en el lóbulo prostático izquierdo. El APE sérico resulta en 1.9 ng/mL. ¿Cuál es la interpretación clínica y la conducta correcta?**

A) El APE normal descarta cáncer; se debe controlar en 3 años
B) Un nódulo pétreo al tacto rectal obliga a realizar biopsia prostática independiente del APE normal
C) Se debe solicitar relación APE libre/total para decidir si se biopsia
D) Indicar tratamiento antibiótico por 4 semanas por sospecha de prostatitis crónica nodular
E) Solicitar ecografía vesicoprostática simple y dar el alta

PREGUNTA 48 1.12.1.001

48. **El informe de anatomía patológica de una biopsia prostática transrectal informa: 'Adenocarcinoma acinar de próstata con patrón Gleason primario 4 en 60% del tejido tumoral y patrón Gleason secundario 3 en 40%'. ¿Cuál es el Score de Gleason y a qué Grupo de Grado ISUP corresponde?**

A) Gleason 3 + 4 = 7; Grupo ISUP 2
B) Gleason 4 + 3 = 7; Grupo ISUP 3
C) Gleason 4 + 4 = 8; Grupo ISUP 4
D) Gleason 3 + 3 = 6; Grupo ISUP 1
E) Gleason 4 + 5 = 9; Grupo ISUP 5

PREGUNTA 49 1.12.1.001

49. **En relación con las garantías explícitas en salud para el Cáncer de Próstata en Chile (GES N° 19), ¿cuál es el plazo máximo normado por ley para realizar la confirmación diagnóstica mediante biopsia prostática desde la sospecha clínica fundada?**

A) 10 días corridos
B) 30 días corridos
C) 60 días corridos
D) 90 días corridos
E) 180 días corridos

PREGUNTA 50 4.03.1.002

50. **Paciente de 83 años con APE 10, adenocarcinoma de próstata Gleason 3+3 en 0,3% de la muestra, estudio de diseminación negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Vigilancia activa con control en 3 meses
B) Prostatectomía radical
C) Radioterapia de haz externo
D) Braquiterapia prostática
E) Deprivación androgénica

PREGUNTA 51 4.03.1.002

51. **Un paciente de 85 años se realiza un antígeno prostático específico, que resulta 10 mg/dl, razón por la cual es sometido a una biopsia prostática transrectal, que se informa como "presencia de adenocarcinoma prostático, Gleason 3+3, presente en el 0,5% del tejido. El estudio de diseminación resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Prostatectomía radical
B) Radioterapia
C) Observar
D) Braquiterapia
E) Hormonoterapia

PREGUNTA 52 4.01.1.013

52. **Hombre de 58 años, activo y deportista, con expectativa de vida mayor a 20 años, es diagnosticado de adenocarcinoma prostático ISUP 2 (Gleason 3+4=7) en 4 de 12 cilindros, con APE basal de 7.5 ng/mL y estadio cT1c. El estudio de etapificación con TAC y cintigrama óseo descarta metástasis. ¿Cuáles son las dos opciones terapéuticas estándar con intención curativa recomendadas para este paciente?**

A) Prostatectomía radical o Radioterapia externa conformacional
B) Quimioterapia con docetaxel o Terapia de deprivación androgénica exclusiva
C) Vigilancia activa o Cistectomía radical
D) Resección transuretral de próstata (RTUP) o Tamsulosina oral
E) Inmunoterapia con pembrolizumab o Castración quirúrgica inmediata

PREGUNTA 53 4.01.1.013

53. **Varón de 73 años con cáncer de próstata metastásico óseo en columna y pelvis inicia tratamiento con el agonista LHRH Leuprolide intramuscular mensual. ¿Cuál es la razón fisiológica por la que se debe prescribir un antiandrógeno oral (como bicalutamida) durante los primeros 14 días desde la primera inyección?**

A) Prevenir la hepatotoxicidad aguda letal inducida por el leuprolide
B) Bloquear el brote inicial de testosterona ('flare up') que puede exacerbar el dolor óseo y causar compresión medular
C) Acelerar la eliminación renal de los metabolitos del leuprolide
D) Evitar la hiponatremia dilucional por secreción inadecuada de ADH
E) Prevenir la necrosis avascular de la cabeza femoral

PREGUNTA 54 4.01.1.013

54. **Paciente de 65 años operado hace 4 meses de prostatectomía radical por adenocarcinoma prostático Gleason 3+4=7 confinado al órgano con márgenes negativos. Consulta en su control postoperatorio por queja de escapes involuntarios de orina al toser, cambiar de posición y caminar rápido, utilizando 2 a 3 absorbentes diarios. El examen neurológico es normal y no hay residuo postmiccional. ¿Cuál es el mecanismo de su incontinencia y la conducta inicial?**

A) Incontinencia de urgencia por vejiga hiperactiva; iniciar oxibutinina oral
B) Incontinencia de esfuerzo por debilidad/lesión esfinteriana; iniciar kinesiterapia del piso pélvico
C) Incontinencia por rebalse; instalar sonda Foley a permanencia
D) Fístula vesicoperineal; indicar cirugía abierta de urgencia
E) Recidiva tumoral retrovesical inmediata; indicar radioterapia pélvica

BLOQUE 4 URO-ONCOLOGÍA

PREGUNTA 55 4.03.1.006

55. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedades de transmisión sexual · 4.03.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedades de transmisión sexual. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 4.03.1.019

56. **Un recién nacido, con antecedente de pielectasia bilateral, diagnosticada por ecografía obstétrica, presenta retraso en la eliminación de orina, por lo que se realiza una ecografía abdominal al tercer día de vida, que visualiza hidroureteronefrosis bilateral, asociada a una vejiga de paredes engrosadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Valvas uretrales posteriores
B) Síndrome de Prune Belly
C) Reflujo vésico-ureteral
D) Vejiga neurogénica
E) Megauréter congénito

PREGUNTA 57 4.03.2.009

57. **Un paciente de 46 años presenta un accidente, resultando con una fractura de pelvis. Presenta dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal y no ha podido orinar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Pedir un TAC de abdomen y pelvis
B) Solicitar resonancia magnética
C) Realizar cistoscopía
D) Instalar sonda Foley
E) Instalar cistostomía

PREGUNTA 58 4.03.2.009

58. **Un paciente de 24 años sufre un accidente de tránsito a alta velocidad. Ingresa adolorido, con sangre fresca por uretra. Está en buenas condiciones, con estabilidad hemodinámica y sin signos de fracturas en el examen físico. La tomografía axial computada de tórax abdomen y pelvis muestra fractura de pelvis no desplazada, vejiga distendida, sin líquido libre peritoneal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Pielografía de eliminación
B) UroTAC
C) Uretrocistografía retrógrada
D) Ecotomografía pélvica
E) Resonancia magnética nuclear de pelvis

PREGUNTA 59 4.03.2.009

59. **Un paciente de 42 años sufre un accidente automovilístico, resultado con múltiples traumatismos. Al examen físico tiene movilidad de las extremidades inferiores, sin signos de fractura y examen genital con uretrorragia. Las radiografías confirman una fractura de pelvis estable. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Pielografía de eliminación endovenosa
B) Uretrocistografía retrógrada
C) Cistoscopía
D) TAC de pelvis
E) Resonancia magnética nuclear de pelvis RECONSTRUCCIÓN EUNACOM DICIEMBRE 2019 Dr. Guillermo Guevara Aliaga SEGUNDA PARTE Pregunta 181) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdadera?

PREGUNTA 60 1.12.1.002

60. **Hombre de 27 años consulta por nódulo palpable indoloro en testículo derecho de 1 mes. La ecografía confirma masa sólida intratesticular de 2.5 cm. Los marcadores séricos muestran AFP 240 ng/mL y b-hCG normal. ¿Cuál es el abordaje quirúrgico y la conducta inicial correcta?**

A) Biopsia con aguja gruesa a través de la piel del escroto bajo anestesia local
B) Orquiectomía radical por abordaje inguinal con clampeo alto del cordón espermático
C) Enucleación simple del nódulo por incisión escrotal con biopsia rápida
D) Observación con ecografía seriada en 3 meses para evaluar crecimiento
E) Quimioterapia con bleomicina antes de cualquier procedimiento quirúrgico

PREGUNTA 61 1.12.1.002

61. **En un paciente de 30 años con masa testicular resecada mediante orquiectomía inguinal, el informe preliminar de biopsia describe 'Seminoma clásico puro'. Sin embargo, los exámenes de sangre preoperatorios y postoperatorios demuestran persistentemente una Alfafetoproteína (AFP) de 350 ng/mL (valor normal < 8 ng/mL). ¿Cuál es la implicancia clínica de este hallazgo?**

A) El diagnóstico es correcto, ya que el 50% de los seminomas puros secretan AFP
B) El seminoma puro NUNCA produce AFP; la elevación de AFP descarta seminoma puro y obliga a tratar al paciente como un No Seminoma
C) La AFP elevada se debe a necrosis tumoral y no modifica la conducta terapéutica del seminoma
D) La elevación de AFP indica únicamente insuficiencia hepática secundaria a fármacos anestésicos
E) Indica que el paciente tiene un teratoma benigno maduro sin potencial invasor

PREGUNTA 62 1.12.1.002

62. Hombre de 22 años operado de orquiectomía inguinal derecha por tumor no seminomatoso. El TAC de tórax, abdomen y pelvis no muestra adenopatías ni lesiones a distancia. Antes de iniciar la quimioterapia adyuvante protocolizada, ¿cuál es la medida preventiva de soporte que debe ofrecerse obligatoriamente al paciente?

A) Criopreservación de semen en banco de esperma
B) Vacunación antineumocócica conjugada
C) Suplementación con testosterona intramuscular mensual
D) Instalación de reservorio venoso subcutáneo profiláctico
E) Nefrectomía profiláctica ipsilateral

PREGUNTA 63 1.12.1.002

63. ¿Cuál de los siguientes factores constituye el factor de riesgo mejor establecido para el desarrollo de cáncer testicular de células germinales?

A) Varicocele izquierdo de larga data
B) Criptorquidia o testículo no descendido
C) Infección urinaria recurrente en la infancia
D) Uso prolongado de ropa interior ajustada
E) Traumatismos testiculares a repetición en deportistas

PREGUNTA 64 4.03.1.022

64. Un paciente de presenta dolor abdominal en el flanco izquierdo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra un tumor renal sólido, de 2,5 cm de diámetro, en el polo superior del riñón derecho. Se solicita un TAC, que confirma el tumor renal de aspecto sólido y que capta contraste. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Nefrectomía radical
B) Nefrectomía parcial
C) Nefroureterectomía
D) Iniciar inhibidores de la tirosinasa
E) Realizar seguimiento ecográfico

PREGUNTA 65 4.03.1.022

65. Mujer de 53 años consulta por control ginecológico. En la ecografía pelviana y abdominal de rutina se describe en el riñón derecho una lesión sólida hiperecogénica exofítica de 3.2 cm en el polo inferior. La paciente está asintomática. ¿Cuál es el examen confirmatorio de elección para caracterizar la lesión y planificar la conducta?

A) Biopsia renal percutánea con aguja de corte bajo ecografía
B) TAC de abdomen y pelvis trifásico con contraste endovenoso
C) Resonancia magnética con difusión sin contraste
D) Cistoscopía diagnóstica con citología de orina de lavado piélico
E) Cintigrama renal con DMSA para evaluar función relativa

PREGUNTA 66 4.03.1.022

66. Hombre de 60 años con diagnóstico tomográfico de carcinoma renal de células claras de 3.8 cm en el tercio medio exofítico del riñón derecho, sin metástasis. Presenta creatinina normal y no tiene comorbilidades graves. ¿Cuál es el tratamiento curativo de elección recomendado actualmente por las guías urológicas y el GES N° 76?

A) Nefrectomía radical derecha con vaciamiento ganglionar extenso
B) Nefrectomía parcial derecha nefro-preservadora
C) Radioterapia estereotáctica corporal ablativa (SBRT)
D) Terapia blanco con sunitinib oral durante 6 meses
E) Embolización arterial renal percutánea curativa

PREGUNTA 67 4.03.1.003

67. Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es:

A) Cistitis hemorrágica
B) Cáncer de vejiga
C) Cáncer renal.
D) Tuberculosis renal
E) Infección urinaria

PREGUNTA 68 4.03.1.003

68. Un paciente de 67 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, consulta por hematuria de 4 días de evolución, abundante, con coágulos. No ha presentado disuria, ni poliaquiuria, ni mal olor en la orina, ni dolor. Su examen de orina muestra abundantes eritrocitos por campo, sin

A) Cáncer renal
B) Cáncer de vejiga
C) Cáncer de uréter
D) Cáncer de próstata
E) Cistitis intersticial

PREGUNTA 69 4.03.1.010

69. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hematuria · 4.03.1.010] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hematuria. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 70 4.03.1.023

70. **Hombre de 67 años, fumador inveterado, consulta por dos episodios de orina con sangre roja y coágulos en la última semana, sin ningún tipo de dolor ni molestia miccional. El examen físico general y urológico no muestra alteraciones. El sedimento descarta infección urinaria. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para visualizar directamente la lesión y confirmar la sospecha de cáncer de vejiga?**

A) Urografía retrógrada con placa postmiccional
B) Cistoscopía con eventual resección transuretral de la lesión
C) Antígeno prostático específico y ecografía prostática transrectal
D) Resonancia magnética pélvica simple
E) Citología urinaria seriada como método diagnóstico exclusivo

PREGUNTA 71 4.03.1.023

71. **Tras realizar una resección transuretral de vejiga (RTUV) de una masa vegetante en la pared lateral vesical en un paciente de 62 años, el patólogo informa: 'Carcinoma urotelial de alto grado que infiltra la lámina propia pero respeta la capa muscular propia; se identifican haces indemnes de músculo detrusor en la muestra (Estadio T1)'. ¿Cuál es el tratamiento adyuvante de elección para reducir el riesgo de recidiva y progresión?**

A) Cistectomía radical inmediata con conducto ileal de Bricker
B) Instilaciones intravesicales con BCG (Bacilo de Calmette-Guérin)
C) Radioterapia externa pélvica conformacional
D) Quimioterapia sistémica con esquema MVAC por 6 ciclos
E) Observación sin terapia adicional con control cistoscópico en 5 años

PREGUNTA 72 4.03.2.002

72. **[URGENCIA: Hematuria masiva · 4.03.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hematuria masiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

BLOQUE 5 INFECCIONES UROLÓGICAS, QUISTES & HEMATURIA

PREGUNTA 73 4.03.1.008

73. **Un paciente masculino, de 30 años, consulta por diminución del calibre miccional, asociada a disuria de esfuerzo de varios meses de evolución. Tiene antecedente de un trauma perineal hace 3 años atrás. Al examen físico tiene genitales externos normales y su tacto rectal demuestra una próstata pequeña y blanda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de próstata
B) Uretritis
C) Hiperplasia prostática benigna
D) Estenosis uretral
E) Urolitiasis

PREGUNTA 74 4.03.1.021

74. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Reflujo vésico ureteral · 4.03.1.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Reflujo vésico ureteral. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 75 1.11.1.006

75. **Hombre de 42 años consulta por cuadro de 24 horas de fiebre de 39.5 °C, calofríos, dolor perineal sordo que empeora al sentarse y disuria. Al tacto rectal suave se palpa una próstata caliente, tumefacta y extremadamente dolorosa. ¿Cuál de las siguientes acciones está FORMALMENTE CONTRAINDICADA en el manejo de este paciente?**

A) Tomar urocultivo por chorro medio antes de iniciar antibióticos
B) Realizar masaje prostático vigoroso para obtener secreción uretral diagnóstica
C) Administrar antipiréticos y AINEs para el alivio del dolor
D) Indicar ciprofloxacino oral por 4 semanas completas
E) Realizar cistostomía suprapúbica si presenta retención aguda de orina

PREGUNTA 76 1.11.1.006

76. **Varón de 50 años con diagnóstico clínico de prostatitis bacteriana aguda que se encuentra hemodinámicamente estable y tolerando adecuadamente la vía oral. Se inicia tratamiento con ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas. ¿Cuál es la duración mínima recomendada de este tratamiento antibiótico para asegurar la erradicación bacteriana y prevenir la prostatitis crónica?**

A) 3 a 5 días
B) 7 a 10 días
C) 21 a 28 días (3 a 4 semanas)
D) 6 meses ininterrumpidos
E) Hasta 48 horas después de que ceda la fiebre

PREGUNTA 77 1.11.1.006

77. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 78 1.11.1.006

78. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 79 1.11.1.006

79. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 80 1.09.1.001

80. **Mujer de 54 años asintomática se realiza una ecografía abdominal como parte de un chequeo preventivo. El informe describe: 'En polo superior del riñón izquierdo se observa lesión anecogénica de 3.8 cm, redondeada, de paredes delgadas e imperceptibles, con refuerzo acústico posterior nítido y sin tabiques ni calcificaciones internas'. Examen físico y función renal normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar a la paciente y darle el alta sin necesidad de seguimiento
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste para descartar malignidad
C) Programar punción percutánea aspirativa del quiste para análisis citológico
D) Repetir ecografía renal cada 6 meses por 3 años consecutivos
E) Derivar a urología para quistectomía laparoscópica electiva

PREGUNTA 81 1.09.1.001

81. Hombre de 35 años con diagnóstico de Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD) e hipertensión arterial en tratamiento consulta en urgencias por cefalea súbita e hiperaguda de máxima intensidad ('la peor cefalea de su vida'), acompañada de vómitos explosivos y rigidez de nuca. ¿Cuál es la complicación vascular subyacente más probable que explica este cuadro?

A) Trombosis de la vena renal bilateral
B) Rotura de aneurisma sacular intracraneal del polígono de Willis con hemorragia subaracnoidea
C) Encefalopatía hipertensiva con microhemorragias pontinas
D) Rotura de quiste renal infectado con shock séptico
E) Disección de aorta torácica tipo A

PREGUNTA 82 1.09.1.001

82. En el enfrentamiento clínico sistemático de Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 83 1.09.1.001

83. En el enfrentamiento clínico sistemático de Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 84 1.09.1.001

84. En el enfrentamiento clínico sistemático de Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 85 4.03.1.018

85. [ATENCIÓN PRIMARIA: Lesiones quísticas del riñón · 4.03.1.018] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lesiones quísticas del riñón. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 86 1.07.1.001

86. Hombre de 24 años consulta por orinas oscuras tipo 'coca-cola' tras un cuadro de faringoamigdalitis hace 12 días. Al examen físico: PA 148/94 mmHg y leve edema bipalpebral. El sedimento de orina revela abundantes glóbulos rojos con 85% de formas dismórficas, acantocitos en 8% y cilindros hemáticos. Proteinuria de 1.2 g/24 horas. ¿Cuál es el origen de la hematuria y el paso siguiente más adecuado?

A) Origen urológico; solicitar Uro-TAC con contraste urgente
B) Origen glomerular; derivar a nefrología para estudio de síndrome nefrítico
C) Origen prostático; iniciar tamsulosina oral y solicitar APE
D) Infección urinaria baja; indicar ciprofloxacino por 14 días
E) Litiasis ureteral silente; indicar abundante hidratación y analgesia

PREGUNTA 87 1.07.1.001

87. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o de laboratorio en un paciente con hematuria permite descartar con mayor certeza el origen glomerular del sangrado?

A) Presencia de coágulos sanguíneos macroscópicos en la orina emitida
B) Orina de aspecto turbio y espumoso
C) Presencia de hipertensión arterial asociada
D) Microhematuria aislada sin proteinuria
E) Aparición de hematuria posterior a ejercicio extenuante

PREGUNTA 88 1.07.1.001

88. En el enfrentamiento clínico sistemático de Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 89 1.07.1.001

89. En el enfrentamiento clínico sistemático de Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 90 1.07.1.001

90. En el enfrentamiento clínico sistemático de Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas (Variante de Práctica 4) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 — Respuesta: A — Balanitis, balano postitis

4.03.1.001 · Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Balanitis, balano postitis" (4.03.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 2 — Respuesta: D — Fimosis, parafimosis

4.03.1.009 · Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 114). Evalúa el manejo clínico de Fimosis, parafimosis según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 3 — Respuesta: A — Parafimosis

4.03.2.003 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Parafimosis" como urgencia clínica (4.03.2.003), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 4 — Respuesta: B

Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

4.01.1.007 · Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo · GES

El TAC de abdomen y pelvis sin contraste (Pielotac) es el estándar de oro para el estudio de la litiasis urológica. Posee una sensibilidad y especificidad >98%, permitiendo visualizar cálculos de cualquier tamaño y composición (incluso los de ácido úrico que son radiolúcidos en radiografía simple). Permite medir con precisión milimétrica el lito y objetivar el grado de hidronefrosis para definir si corresponde manejo expectante o intervención urológica. Perla. La ecografía renal tiene menor rendimiento para litiasis ureterales intermedias y se reserva para embarazadas.

PREGUNTA 5 — Respuesta: B

Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

4.01.1.007 · Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo · GES

Los cálculos ureterales entre 5 y 10 mm presentan una probabilidad intermedia de eliminación espontánea. La guía clínica internacional y nacional recomienda el uso de Terapia Médica Expulsiva (TME) mediante alfa-1 bloqueantes como Tamsulosina (0.4 mg una vez al día) durante un periodo de 2 a 4 semanas. Este fármaco relaja el músculo liso ureteral distal, duplicando la tasa de expulsión y reduciendo significativamente los requerimientos de analgesia de rescate. Perla. Si al cabo de 4 semanas no se ha expulsado el lito, se programa resolución quirúrgica activa.

PREGUNTA 6 **Respuesta: C**

Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

4.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente presenta una Injuria Renal Aguda postrenal anúrica en un riñón único funcionante. Esto constituye una emergencia urológica absoluta que amenaza de forma inminente la vida y la sobrevida del parénquima renal. La conducta mandatoria es la descompresión urgente de la vía urinaria mediante la colocación retrógrada de un catéter Doble J o la punción anterógrada de una nefrostomía percutánea. Trampa. La infusión de fluidos masivos o diuréticos de asa en una vía urinaria obstruida está contraindicada porque provoca edema pulmonar agudo y mayor daño glomerular.

PREGUNTA 7 **Respuesta: C**

Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

4.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La hidroclorotiazida (diurético tiazídico) es el tratamiento farmacológico de primera línea en la urolitiasis cálcica recidivante asociada a hipercalciuria idiopática. Las tiazidas estimulan la reabsorción activa de calcio en el túbulo contorneado distal, disminuyendo significativamente la concentración de calcio en la orina y evitando la sobresaturación de sales de oxalato. Adicionalmente, confiere protección mineral ósea. Perla. La furosemida por el contrario es calciúrica y aumentaría la formación de litos.

PREGUNTA 8 **Respuesta: D**

Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

4.03.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Las ITU recurrentes se deben 1. Confirmar con urocultivo, 2. Estudiar en búsqueda de una causa tratable y 3. Manejar con profilaxis antibiótica, hasta resolver la causa de base. Si hay clara relación con acGvidad sexual, la profilaxis antibiótica poscoital disminuye las recurrencias.

PREGUNTA 9 **Respuesta: A**

Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

4.03.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Infección urinaria específica" (4.03.1.016), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 10 **Respuesta: A**

Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

4.03.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Prevención de la Litiasis Urinaria: La medida más importante para prevenir la formación de cálculos renales es aumentar la ingesta de agua. Dependiendo del tipo de cálculo y las alteraciones metabólicas, se pueden recomendar medidas adicionales como tiazidas para la hipercalciuria, alopurinol para la hiperuricemia/hiperuricosuria, y una dieta baja en proteínas animales para la hiperoxaluria.

PREGUNTA 11 **Respuesta: B**

Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

4.03.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El cólico renal se estudia con PieloTAC (TAC sin contraste). El UroTAC se utiliza como estudio de la hematuria, después de descartar TU, cuando se sospecha cáncer, ya que dibuja bien la vía urinaria.

PREGUNTA 12 **Respuesta: B**

Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presencia de uretrorragia y hematoma perineal en mariposa tras trauma pélvico o perineal es patognomónica de rotura de uretra (generalmente bulbar o membranosa). En este escenario, el cateterismo vesical a ciegas con sonda Foley está formalmente contraindicado porque puede convertir una rotura parcial en una sección uretral completa o provocar falsas vías e infección masiva. La conducta de elección inmediata para resolver la retención urinaria es la cistostomía suprapúbica por punción. Perla. El estudio posterior de la rotura se realiza con uretrocistografía retrógrada.

PREGUNTA 13 **Respuesta: B**

Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tras la descompresión rápida de una obstrucción urinaria severa y prolongada (especialmente con volúmenes > 1.000 mL), puede desencadenarse el síndrome de diuresis post-obstructiva. Se produce por la pérdida del gradiente de concentración medular, la excreción forzada de urea retenida y la insensibilidad tubular transitoria a la ADH, pudiendo generar diuresis masiva (> 200 mL/h) con deshidratación grave, hiponatremia o hipokalemia si no se reponen parcialmente las pérdidas hidrosalinas. Perla. La hematuria ex vacuo es un evento benigno autolimitado.

PREGUNTA 14 **Respuesta: A**

Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

4.03.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Uropatía alta" (4.03.1.026), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

4.03.1.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Uropatía obstructiva baja" (4.03.1.027), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 16 **Respuesta: C**

Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

4.03.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La sospecha es una prostatitis aguda, por la clínica de ITU e importante elevación del APE. Se trata con ciprofloxacino. Se puede estudiar con cultivo de líquido seminal. Luego de tratarla, se debe esperar a repetir el APE.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

4.03.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Retención urinaria aguda: manejo inmediato = sonda Foley para drenaje vesical. Alivia el dolor y previene daño renal. Cistostomía solo si falla la sonda. Alfa-bloqueador se agrega DESPUÉS del episodio agudo para prevención de recurrencia.

PREGUNTA 18 **Respuesta: A**

Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

4.03.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Primero se deben indicar alfa-ANTAgonistas, porque no hay ninguna indicación estricta de cirugía. Pero de las opciones que aparecen la RTU es la única aceptable (aunque no se dice el tamaño de la próstata, porque si es mayor a 60cc, se debe hacer cirugía abierta y no RTU). Los inhibidores de la 5 alfa reductasa no sirven. La biopsia solo está indicada si TR positivo o APE mayor a 4 o velocidad de APE mayor a 0,75.

BLOQUE 2 UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 Respuesta: A Criptorquídea

4.03.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Criptorquídea" (4.03.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 20 Respuesta: C Hidronefrosis

4.03.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta muy discutible y de manejo de especialista, que no debería preguntarse. Que tenga solo 10% de captación y adelgazamiento cortical muestra que el riñón probablemente tiene daño severo e irrecuperable, por lo que estaría indicada la nefrectomía. Eso sí, antes debería pedirse una TAC, ya que igual se puede intentar salvar ese 10% con una pieloplastía. Discutimos mucho esta pregunta con varios especialistas y aunque no hubo consenso, dejaremos como correcta la nefrectomía. Nuevamente, en fin... así es el Eunacom y lo más importante es no pelear con él, sino seguir respondiendo.

PREGUNTA 21 Respuesta: E Priapismo

4.03.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

El priapismo isquémico (erección dolorosa y mayor a 4 horas, que suele perder la turgencia del glande y cuerpo esponjoso) es una urgencia y se maneja en primer lugar con fenilefrina intracavernosa, seguido luego de manejo invasivo con drenaje y lavado con SF de los cuerpos cavernosos y, si falla, con derivación cavernoesponjosa. También se deben buscar causas secundarias (ej. drepanocitosis o leucemia) y, además, distinguirlo del priapismo de alto flujo o no isquémico (que es por hiperflujo arterial y generalmente no duele ni tiene riesgo de complicarse con disfunción eréctil permanente, por lo que se observa o maneja con compresas de hielo para acelerar su desaparición).

PREGUNTA 22 Respuesta: B

Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

4.01.1.025, 1.08.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El cuadro clínico corresponde a una Incontinencia Urinaria de Urgencia en el contexto de un Síndrome de Vejiga Hiperactiva, caracterizado por contracciones no inhibidas del detrusor con residuo postmiccional normal. El tratamiento farmacológico de primera línea consiste en antimuscarínicos (como Oxibutinina o Tolterodina) o en el agonista beta-3 adrenérgico Mirabegrón (preferido en pacientes geriátricos por su menor perfil de efectos anticolinérgicos centrales). La cirugía con cabestrillo (TOT) está reservada para la incontinencia de esfuerzo y no tiene utilidad en este cuadro.

PREGUNTA 23 Respuesta: B

Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

4.01.1.025, 1.08.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente presenta el cuadro clásico de Incontinencia Urinaria por Rebalse secundaria a vejiga neurógena diabética atónica (cistopatía diabética). La denervación autonómica sensitiva impide censar el llenado vesical, llevando a sobredistensión crónica y goteo por rebalse. El examen no invasivo inicial indispensable es la medición del Residuo Postmiccional (RPM), el cual típicamente estará marcadamente elevado (> 300-500 mL), confirmando la falla de vaciamiento y previniendo la prescripción errónea de anticolinérgicos.

PREGUNTA 24 Respuesta: B

Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

4.01.1.025, 1.08.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Los ejercicios de Kegel consisten en la contracción voluntaria, aislada y repetida de los músculos del suelo pélvico (principalmente el complejo elevador del ano y pubococcígeo) sin contraer simultáneamente la musculatura de la pared abdominal anterior, los glúteos ni los aductores. Se deben realizar en series diarias programadas fuera de la micción. Perla. Interrumpir el chorro miccional al orinar ('stop-flow') no debe usarse como ejercicio regular porque altera el reflejo miccional normal y predispone a infecciones.

PREGUNTA 25 **Respuesta: D**

4.03.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

Tiene una inconGnencia de urgencia. Se trata con medidas de conductuales y de reeducación vesical más kinesioterapia pélvica. De segunda línea, se pueden usar fármacos. Los más usados son los anticolinérgicos (oxibuGnina, tolterodina, cloruro de trospio), por lo que los dejaremos como respuesta correcta. Sin embargo, los agonistas beta 3 adrenérgicos (vivegrón y miravegrón) son una excelente y segura opción, aunque son caros y están poco disponibles en Chile. En adultos mayores, los anticolinérgicos se asocian a desarrollo y agravamiento de demencia, por lo que se prefiere el cloruro de trospio (traspasa menos la barrera hematoencefálica) y o los beta 3 adrenérgicos.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

La clínica descrita es categórica de Torsión Testicular: paciente en grupo etario de máxima incidencia, inicio brusco nocturno, cortejo vegetativo, signo de Gouverneur positivo y reflejo cremastérico ausente. El tiempo de isquemia transcurrido es de apenas 3 horas (dentro de la ventana de máxima viabilidad < 6 horas). Ante alta sospecha clínica, NUNCA se debe postergar la cirugía ni perder tiempo valioso trasladando al paciente para una ecografía; la conducta obligatoria es la exploración quirúrgica inmediata. Perla. Trasladar al paciente costaría horas críticas de viabilidad.

PREGUNTA 27 **Respuesta: B**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

El cuadro clínico es el prototipo de una Torsión de Apéndice Testicular (Hidátide de Morgagni): dolor moderado subagudo en escolar, reflejo cremastérico conservado, testículo en posición normal y el signo patognomónico del 'punto azul' (blue dot sign), correspondiente al apéndice isquémico trombosado visible por transparencia en el polo superior. Esta patología es autolimitada y no pone en riesgo la viabilidad de la gónada; su tratamiento de elección es conservador con reposo y antiinflamatorios no esteroidales (AINEs). Perla. La cirugía se reserva solo para casos atípicos donde no se logre descartar torsión de cordón.

PREGUNTA 28 **Respuesta: B**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

En toda intervención por torsión testicular, la fijación del testículo contralateral (orquidopexia profiláctica contralateral) es un paso quirúrgico formalmente obligatorio y de estándar legal. La anomalía anatómica que predispone a la torsión (la fijación alta de la túnica vaginal o deformidad en 'badajo de campana') es una condición congénita bilateral en más del 80% de los casos. Omitir la orquidopexia contralateral deja al paciente en riesgo latente de torsión del único testículo remanente o sano en el futuro, con riesgo de anorquia e infertilidad.

PREGUNTA 29 **Respuesta: B**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

La inmensa mayoría de las torsiones testiculares (> 80%) ocurren en dirección medial (hacia la línea media del cuerpo). Por esta razón, la maniobra de destorsión manual externa consiste en rotar el testículo en sentido opuesto: de medial hacia lateral, lo que mnemotécnicamente se describe como 'abrir las páginas de un libro' (para el testículo derecho, en sentido antihorario; para el izquierdo, en sentido horario). Si la maniobra es exitosa, el paciente experimenta un alivio dramático inmediato del dolor; no obstante, la exploración quirúrgica para orquidopexia bilateral sigue siendo mandatoria.

PREGUNTA 30 **Respuesta: C**

4.03.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

Es un tumor testicular, confirmado con la ecografía, por lo que se debe realizar la orquiectomía radical, con biopsia excisional.

PREGUNTA 31 **Respuesta: A**

4.03.2.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

Cuadro clásico. Que sea adolescente orienta aún más a torsión testicular, por sobre el de hidátide (niños más chicos).

PREGUNTA 32 **Respuesta: B**

Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En hombres menores de 35 años sexualmente activos, la orquiepididimitis aguda es causada fundamentalmente por patógenos de transmisión sexual: Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. El esquema antibiótico normado de primera línea consiste en la combinación de Ceftriaxona (500 mg o 1 g IM en dosis única para cubrir el gonococo) asociada a Doxiciclina (100 mg cada 12 horas oral por 10 a 14 días para erradicar Chlamydia). Además se debe tratar a la pareja sexual. Perla. El ciprofloxacino no cubre adecuadamente Chlamydia ni gonococo por alta tasa de resistencia.

PREGUNTA 33 **Respuesta: C**

Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En hombres mayores de 35 años, y particularmente en aquellos con patología prostática de base (HPB), obstrucción urinaria baja o instrumentación urológica, la orquiepididimitis se produce por el reflujo retrógrado de orina infectada desde la uretra prostática hacia los conductos eyaculadores y deferentes. En este grupo etario, el microorganismo causante en más del 80% de los casos son las enterobacterias gramnegativas del tracto digestivo, lideradas ampliamente por Escherichia coli.

PREGUNTA 34 **Respuesta: B**

Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La persistencia de fiebre alta, empeoramiento clínico y aparición de una zona fluctuante en el escroto tras 72-96 horas de antibioticoterapia adecuada es altamente sugerente de una complicación supurativa mayor: un **absceso epididimario o testicular**. La conducta mandatoria es confirmar la colección purulenta mediante Ecografía Doppler escrotal urgente y derivar al especialista en urología para hospitalización, antibioticoterapia parenteral de amplio espectro y drenaje quirúrgico o eventual orquiectomía si el parénquima está destruido.

PREGUNTA 35 **Respuesta: E**

Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

4.03.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una orquiepididimitis clásica.

PREGUNTA 36 **Respuesta: E**

Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

4.03.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

E? La clásica causa de orquiepididimitis es la infección por clamidia y luego gono- rrea (yo marqué Chlamydia). Sin embargo, la E. Coli es la causa más frecuente cuando no hay infección de transmisión sexual y es especialmente frecuente en adultos mayo- res. En este caso, si le creíamos que tenía pareja única, la respuesta probablemente era E. Coli.

BLOQUE 3 URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A**

Disfunción sexual de causa orgánica

4.03.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Disfunción eréctil: primera línea = inhibidores de PDE5 (sildenafil, tadalafil). Contraindicados con nitratos. Enalapril no contraindica su uso. La testosterona solo si hay hipogonadismo confirmado.

PREGUNTA 38 **Respuesta: C** **Infertilidad masculina**

4.03.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

El primer estudio de infertilidad masculina es el espermiograma.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B** Trauma urológico

4.03.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un traumatismo renal (golpe lumbar más hematuria), que se estudia con el Uro TAC. No confundir con la lesión uretral (golpe pélvico más uretrorragia), que se estudia con la UCG.

PREGUNTA 40 **Respuesta: C**

Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

4.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El hallazgo de un varicocele del lado derecho (sitio altamente infrecuente), de aparición tardía en un adulto de 58 años y que característicamente no se colapsa en posición de decúbito dorsal, es un signo de alarma mayor de obstrucción vascular retroperitoneal fija. La causa más temida es un Carcinoma de Células Renales con invasión y trombo tumoral de la vena cava inferior o una compresión tumoral retroperitoneal sobre el drenaje venoso espermático. La conducta obligatoria e inmediata es descartar neoplasia mediante un TAC de abdomen y pelvis con contraste.

PREGUNTA 41 **Respuesta: B**

Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

4.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de una masa escrotal indolora, fluctuante, que engloba por completo al testículo impidiendo su palpación aislada y que presenta una prueba de transiluminación intensamente positiva es patognomónica de un **Hidrocele** (acumulación de líquido seroso claro entre las capas de la túnica vaginal). Los tumores sólidos testiculares, las hernias y los hematoceles son opacos a la luz y arrojan transiluminación negativa.

PREGUNTA 42 **Respuesta: B**

Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

4.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El varicocele clínico palpable asociado a alteración documentada del espermiograma (oligoastenoteratozoospermia) en el contexto de infertilidad de pareja es la indicación formal y de primera línea para la reparación quirúrgica (**Varicocelectomía** microquirúrgica subinguinal o laparoscópica). La ligadura de las venas espermáticas dilatadas disminuye la hipertermia y el estrés oxidativo intratesticular, logrando una mejoría significativa de la concentración y movilidad espermática en más del 60-70% de los pacientes tratados, con aumento de las tasas de embarazo espontáneo. Perla. El uso de testosterona exógena suprime el eje y empeora la infertilidad produciendo azoospermia.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A**

Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

4.03.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hidrocele" (4.03.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 44 **Respuesta: D**

Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

4.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es un quiste del epidídimo. Se observan.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B**

Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

4.03.1.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tiene indicación de ligadura del plexo pampiniforme, tanto por la atrofia testicular, como por el dolor.

PREGUNTA 46 **Respuesta: B**

1.12.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

El paciente presenta un APE total confirmado en la 'zona gris' (4.0 a 10.0 ng/mL) con tacto rectal normal. En este rango, el porcentaje de APE Libre/Total es la herramienta de discriminación más útil: un valor inferior al 15% (en este caso 9%) se asocia a un riesgo de cáncer de próstata superior al 50-60%. La conducta oficial de elección es la confirmación histológica mediante biopsia prostática guiada por ecografía transrectal (GES N° 19). Perla. Iniciar finasteride en este momento enmascararía el APE y retrasaría el diagnóstico.

PREGUNTA 47 **Respuesta: B**

1.12.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

Esta es una de las reglas de oro más repetidas en el examen EUNACOM: el Tacto Rectal y el APE son métodos complementarios y mutuamente independientes. Hasta un 20% de los adenocarcinomas de próstata clínicamente significativos no elevan el APE por encima de 4.0 ng/mL (especialmente tumores muy indiferenciados o localizados). La presencia de un nódulo duro o pétreo al tacto rectal es una indicación absoluta de biopsia prostática transrectal ecoguiada, independientemente de que el APE sea bajo o normal.

PREGUNTA 48 **Respuesta: B**

1.12.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

El score de Gleason se formula sumando primero el patrón arquitectural más frecuente (en este caso el patrón 4, presente en el 60%) seguido del segundo patrón más frecuente (patrón 3, en el 40%), resultando en Gleason 4 + 3 = 7. De acuerdo a la clasificación internacional de la ISUP, el Gleason 4+3 corresponde al Grupo de Grado ISUP 3 (pronóstico desfavorable intermedio), diferenciándose críticamente del Gleason 3+4 (ISUP 2), que posee un curso biológico mucho más favorable. Perla. El primer número siempre representa el patrón predominante.

PREGUNTA 49 **Respuesta: B**

1.12.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

La Guía Clínica AUGE / GES N° 19 establece taxativamente que todo paciente de 15 años y más con sospecha fundada de cáncer de próstata (por tacto rectal sospechoso o APE elevado persistente) tiene derecho legal a la confirmación diagnóstica mediante biopsia dentro de un plazo máximo de 30 días desde la derivación con sospecha. Una vez confirmada la biopsia, el tratamiento curativo o paliativo debe iniciarse dentro de los 60 días.

PREGUNTA 50 **Respuesta: A**

4.03.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

Vigilancia activa con control en 3 meses

PREGUNTA 51 **Respuesta: C**

4.03.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

Caso clínico oficial EUNACOM para Cáncer de próstata.

PREGUNTA 52 **Respuesta: A**

4.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)

En el cáncer de próstata localizado de riesgo intermedio favorable (ISUP 2, Gleason 3+4, APE < 10) en un paciente joven con excelente estado basal y expectativa de vida prolongada (> 10-15 años), las dos alternativas terapéuticas de referencia con demostrada intención curativa y sobrevida global equivalente a 10 y 15 años son la **Prostatectomía Radical** (con o sin preservación de bandeletas neurovasculares) y la **Radioterapia Externa** (asociada o no a hormonoterapia corta). La elección entre ambas depende de la preferencia informada del paciente respecto a los perfiles de efectos secundarios (incontinencia/disfunción eréctil vs toxicidad rectal/urinaria).

PREGUNTA 53 **Respuesta: B**

4.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)

Los agonistas del receptor de GnRH/LHRH (como leuprolide y goserelina) estimulan inicialmente los receptores hipofisarios de forma potente antes de producir su internalización y desensibilización (down-regulation). Durante los primeros 7 a 14 días se produce una elevación transitoria de LH y consecuentemente un aumento en la síntesis de testosterona, fenómeno conocido como **'flare up' tumoral**. En pacientes con metástasis óseas vertebrales, este aumento puede provocar una rápida progresión tumoral con dolor óseo intolerable, retención urinaria o compresión medular aguda. La coadministración de un antiandrógeno periférico (Bicalutamida) bloquea los receptores androgénicos prostáticos y neutraliza este riesgo.

PREGUNTA 54 **Respuesta: B**

4.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)

La incontinencia urinaria post-prostatectomía radical es predominantemente una Incontinencia Urinaria de Esfuerzo secundaria a la alteración o daño por tracción del esfínter uretral estriado y pérdida del soporte anatómico uretral. En los primeros 6 a 12 meses postoperatorios, la inmensa mayoría de los pacientes experimenta una mejoría progresiva sustancial. La conducta inicial obligatoria es la rehabilitación y fortalecimiento del esfínter mediante **kinesiterapia del suelo pélvico** supervisada. La colocación de un esfínter urinario artificial solo se considera tras al menos 1 año de evolución si la incontinencia persiste severa.

BLOQUE 4 URO-ONCOLOGÍA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A**

4.03.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Enfermedades de transmisión sexual

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedades de transmisión sexual" (4.03.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A**

4.03.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Malformaciones congénitas nefrourológicas

La dilatación bilateral, más la vejiga de lucha orienta a obstrucción uretral. La única opción era la de las valvas/válvulas uretrales, que son una malformación relativamente frecuente.

PREGUNTA 57 **Respuesta: E** **Traumatismo uretral** 4.03.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una sección uretral. Está contraindicada la Sonda Foley y Nelaton. Se instala cistostomía. Se estudia con uretrocistografía retrógrada y no con los exámens que ahí aparecían. Se resuelve luego con cirugía.

PREGUNTA 58 **Respuesta: C** **Traumatismo uretral** 4.03.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La sospecha es una sección uretral, por lo que se contraindica la sonda Foley, se estudia con UCG retrógrada, se maneja con cistostomía suprapúbica y, además, con cirugía de reparación uretral.

PREGUNTA 59 **Respuesta: B** **Traumatismo uretral** 4.03.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una sección uretral, la que se estudia con UCG y se trata con cirugía. Recordar que está contraindicada la sonda (también la cistoscopía) y si hay globo vesical se maneja con cistostomía suprapúbica. Segunda parte

---

PREGUNTA 60 **Respuesta: B**

Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

1.12.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Ante la presencia de una masa sólida intratesticular confirmada ecográficamente en un adulto joven con marcadores tumorales positivos, el procedimiento mandatorio inicial es la Orquiectomía Inguinal Radical. La incisión debe realizarse a nivel inguinal (por encima del ligamento inguinal) con clampeo vascular temprano del cordón espermático a nivel del anillo profundo para evitar la diseminación hematógena. La biopsia o abordaje transescrotal está formalmente contraindicada porque abre una vía linfática aberrante hacia los ganglios inguinales superficiales. Perla. Nunca puncionar un testículo con sospecha tumoral.

PREGUNTA 61 **Respuesta: B**

Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

1.12.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Esta es una regla de oro oncológica fundamental: las células de seminoma puro carecen de la capacidad genética y bioquímica para sintetizar Alfafetoproteína (AFP). Por lo tanto, si un paciente con presunto seminoma presenta elevación de AFP en suero, existe obligatoriamente un componente histológico no seminomatoso no identificado en la muestra (habitualmente carcinoma embrionario o tumor del saco vitelino). Para todos los fines terapéuticos y de pronóstico, el paciente DEBE ser reclasificado y tratado con los protocolos de Tumor No Seminomatoso (los cuales son radiorresistentes y requieren quimioterapia BEP).

PREGUNTA 62 **Respuesta: A**

Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

1.12.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Dado que el cáncer testicular afecta a hombres jóvenes en plena edad fértil y que los esquemas quimioterápicos con cisplatino (BEP) o la linfadenectomía retroperitoneal (que puede producir eyaculación retrógrada permanente por lesión de los nervios simpáticos hipogástricos) conllevan un alto riesgo de azoospermia o infertilidad transitoria o permanente, es un estándar ético y médico mandatorio ofrecer y gestionar la **criopreservación de semen** previo al inicio de cualquier terapia oncológica adyuvante.

PREGUNTA 63 **Respuesta: B**

Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

1.12.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La **criptorquidia** (falla en el descenso testicular hacia el escroto) es el factor de riesgo congénito más fuertemente asociado al cáncer testicular, multiplicando el riesgo entre 4 y 10 veces en comparación con la población general. Si bien la orquidopexia quirúrgica temprana (antes del primer año de vida) mejora el potencial de fertilidad y disminuye en parte el riesgo, no lo iguala al de la población normal, y además confiere un riesgo aumentado para el testículo contralateral normalmente descendido.

PREGUNTA 64 **Respuesta: B**

Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

4.03.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Todo tumor renal sólido (con pocas excepciones) se presume un cáncer renal. Si son menores a 7 cm (antes era 4), se tratan con nefrectomía parcial (más aún en monorrenos o insuficientes renales). Si son más de 7 cm se tratan con nefrectomía radical. Si tienen metástasis ganglionares, van a terapia paliativa (la inmunoterapia puede servir, pero poco y es muy cara). Si es de pelvis renal, se hace nefroureterectomía.

PREGUNTA 65 **Respuesta: B**

Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

4.03.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Ante el hallazgo ecográfico de una masa renal sólida en un paciente adulto, el estudio diagnóstico de elección estándar es la **Tomografía Computarizada de abdomen y pelvis multifásica (trifásica) con contraste endovenoso**. Este examen permite confirmar si la lesión es sólida o quística, evaluar el realce tras el contraste (criterio cardinal de carcinoma de células renales si aumenta > 15-20 UH), definir la anatomía quirúrgica vascular y descartar invasión de la vena renal o ganglios retroperitoneales. La biopsia percutánea preoperatoria no está indicada de rutina.

PREGUNTA 66 **Respuesta: B**

4.03.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

Para tumores renales sólidos en estadio clínico T1a (≤ 4 cm de diámetro) localizados, la **Nefrectomía Parcial** (resección del tumor con un margen libre de parénquima sano) es el tratamiento curativo de referencia de primera elección. Ofrece tasas de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global idénticas a la nefrectomía radical completa, pero preserva significativamente mayor masa nefronal funcionante, reduciendo a largo plazo el riesgo de enfermedad renal crónica, diálisis y eventos cardiovasculares adversos.

PREGUNTA 67 **Respuesta: B**

4.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

El cáncer de vejiga es la causa más frecuente de hematuria monosintomática (sin otros síntomas; si en cambio viene con síntomas de ITU, es ITU; si viene con síntomas de litiasis, es litiasis, etc.) en el adulto, en especial si es un paciente fumador. Las demás opciones tienen otros síntomas. La clínica clásica del cáncer renal es: masa, hematuria y fiebre (más ictericia en algunos casos).

PREGUNTA 68 **Respuesta: B**

4.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

La hematuria monosintomática del adulto sugiere un cáncer de vejiga. El antecedente de fumar, también.

PREGUNTA 69 **Respuesta: A**

4.03.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hematuria" (4.03.1.010), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 70 **Respuesta: B**

4.03.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

En un paciente con alta sospecha de cáncer de vejiga por hematuria macroscópica indolora y antecedente de tabaquismo severo, la **Cistoscopía** es el estándar de oro diagnóstico indiscutido. Permite la inspección visual endoscópica directa de toda la mucosa vesical, cuello y uretra, localizar el número, tamaño y morfología de las lesiones papilares y proceder en el mismo acto quirúrgico a la Resección Transuretral de Vejiga (RTUV) diagnóstica y terapéutica. La citología de orina es complementaria pero no reemplaza la cistoscopía.

PREGUNTA 71 **Respuesta: B**

4.03.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

El paciente presenta un Cáncer de Vejiga No Músculo Invasivo (CVNMI) de alto riesgo estadio T1 (invasión de lámina propia pero sin penetración a la capa muscular detrusor). Tras una RTUV completa, el tratamiento adyuvante estándar de primera línea para prevenir la alta tasa de recurrencia y progresión a cáncer invasivo son las **instilaciones intravesicales con BCG (Bacilo de Calmette-Guérin)** en esquema de inducción semanal durante 6 semanas seguido de mantención por 1 a 3 años. La cistectomía radical se reserva para falla de BCG o invasión muscular (≥ T2).

PREGUNTA 72 **Respuesta: A**

4.03.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hematuria masiva" como urgencia clínica (4.03.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 73 **Respuesta: D** Estenosis uretral 4.03.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Parece una estenosis uretral postraumática. Dada la edad y el tacto rectal, es im- probable que sean las demás causas de UOB.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A** Reflujo vésico ureteral 4.03.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Reflujo vésico ureteral" (4.03.1.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 75 **Respuesta: B**

Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia 1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En la prostatitis bacteriana aguda, el **masaje prostático está formalmente contraindicado**. La compresión manual de una glándula prostática agudamente infectada y microabscedada puede provocar la diseminación bacteriana masiva a través del plexo venoso periprostático hacia la circulación sistémica, precipitando una bacteriemia fulminante y shock séptico. Además, el procedimiento es extraordinariamente doloroso. El diagnóstico se confirma con la clínica típica y urocultivo simple de orina emitida. Perla. El test de Stamey con masaje se reserva únicamente para la prostatitis crónica en frío.

PREGUNTA 76 **Respuesta: C**

Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia 1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A diferencia de las cistitis o pielonefritis no complicadas que requieren cursos antibióticos de 3 a 7 días, la **prostatitis bacteriana aguda requiere esquemas prolongados de 3 a 4 semanas (21 a 28 días)**. Esto se debe a que la barrera hemato-prostática y el estroma fibromuscular dificultan la penetración y concentración tisular del fármaco una vez que cede la inflamación aguda inicial. Los tratamientos breves conllevan una altísima tasa de recidiva, persistencia de microfocos bacterianos y evolución tórpida hacia una prostatitis bacteriana crónica de muy difícil erradicación.

PREGUNTA 77 **Respuesta: A**

Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia 1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia, la conducta médica prioritaria es: La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 78 **Respuesta: A**

Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia 1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia, la conducta médica prioritaria es: La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 79 **Respuesta: A**

Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia

1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia, la conducta médica prioritaria es: La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La lesión reúne todos los criterios ecográficos universales de un **Quiste Renal Simple Benigno (Categoría Bosniak I)**: anecogénico, paredes no visibles, refuerzo posterior y sin ecos internos ni tabiques. Los quistes simples son variantes anatómicas extremadamente prevalentes en adultos mayores de 50 años que carecen de potencial de malignización. No requieren confirmación tomográfica, punción aspirativa ni controles ecográficos seriados. La conducta médica correcta es tranquilizar a la paciente y darle el alta.

PREGUNTA 81 **Respuesta: B**

Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Entre un 8 y un 10% de los pacientes con Poliquistosis Renal Autosómica Dominante presentan aneurismas saculares congénitos de las arterias cerebrales del polígono de Willis (aneurismas de Berry), porcentaje que asciende al 20% si hay antecedentes familiares de aneurisma o ACV. La rotura de uno de estos aneurismas desencadena una **Hemorragia Subaracnoidea (HSA)** clásica, manifestada por cefalea en trueno súbita de máxima intensidad, signos meníngeos y riesgo vital inminente, requiriendo TAC de encéfalo sin contraste urgente.

PREGUNTA 82 **Respuesta: A**

Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante, la conducta médica prioritaria es: El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 83 **Respuesta: A**

Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante, la conducta médica prioritaria es: El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 84 **Respuesta: A**

Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante, la conducta médica prioritaria es: El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 85 **Respuesta: A**

Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

4.03.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lesiones quísticas del riñón" (4.03.1.018), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 86 **Respuesta: B**

Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El hallazgo de hematíes dismórficos en más del 80%, acantocitos (células G1) > 5% y la presencia patognomónica de **cilindros hemáticos** asociados a proteinuria y síndrome nefrítico (hipertensión y edema postinfeccioso) confirman de forma inequívoca el **origen glomerular** del sangrado. En este escenario están contraindicados los estudios urológicos invasivos (cistoscopía) y la conducta correcta es la derivación a Nefrología para estudio etiológico y eventual biopsia renal.

PREGUNTA 87 **Respuesta: A**

Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presencia de **coágulos macroscópicos en la orina descarta de manera prácticamente categórica el origen glomerular**. En el túbulo renal existen altas concentraciones de activador tisular del plasminógeno y uroquinasa que degradan la fibrina, impidiendo la formación de coágulos cuando el sangrado se origina en el glomérulo o túbulos proximales. Por lo tanto, cualquier paciente que elimine coágulos sanguíneos presenta un sangrado de origen extraglomerular o urológico (pelvis renal, uréter, vejiga, próstata o uretra).

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas, la conducta médica prioritaria es: La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 89 **Respuesta: A**

Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas, la conducta médica prioritaria es: La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas, la conducta médica prioritaria es: La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.
